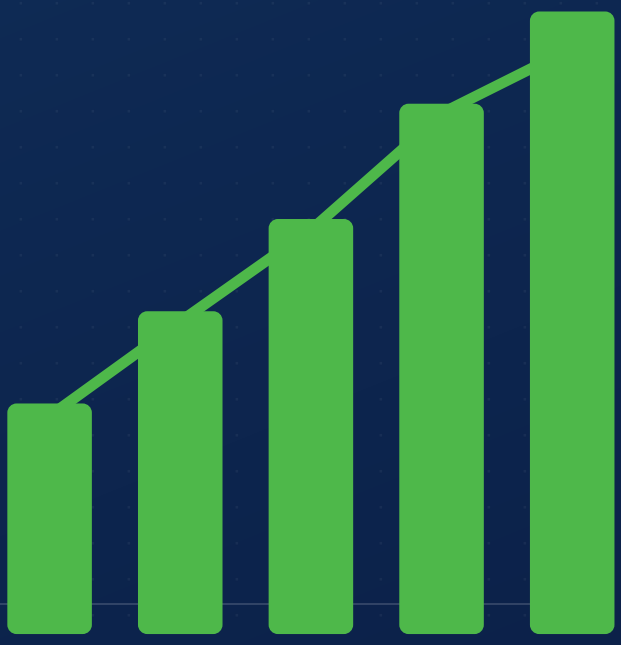
EBOOK PANDUAN

Panduan Direksi Rumah Sakit Menyusun Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Sesuai Permenkes 6/2026

Susun Peraturan Internal Rumah Sakit — bylaws korporasi & staf medis — sesuai struktur Permenkes 6/2026 tanpa perlu konsultan hukum mahal.



"Belajar. Praktik. Naik Level."

Diterbitkan oleh **Naik Level Id**
Panduan belajar praktis & aplikatif

BAB 1

Mengapa Peraturan Internal RS Harus Disusun Ulang

Saya tidak akan mengawali dengan teori panjang. Kita langsung ke masalah: banyak RS masih memakai Peraturan Internal RS (Hospital Bylaws) versi lama yang mencampur aturan korporasi dan aturan staf medis dalam satu dokumen tebal. Permenkes 6/2026 mengubah pendekatan ini secara struktural—bukan sekadar ganti nama atau tambah pasal. Kalau dokumen Anda masih lama, risiko ditolak saat verifikasi legalitas atau akreditasi sangat nyata.

> ⛔ **Waspada: Jangan menganggap revisi ini cukup dengan mengganti kop dan memberi nomor ulang. Struktur lama yang masih mencampur kewenangan pemilik, Direksi, dan Komite Medik dalam satu bab akan langsung terlihat tidak sesuai saat penilaian tata kelola.**

Apa sebenarnya yang berubah? Permenkes 6/2026 menuntut Peraturan Internal RS disusun sebagai dua dokumen terpisah tetapi saling bertautan. Pertama, **bylaws korporasi** mengatur hubungan pemilik/pemegang saham, organ pemilik, Dewan Pengawas jika ada, Direksi, pengangkatan pejabat struktural, serta mekanisme pengambilan keputusan korporasi. Kedua, **bylaws staf medis** mengatur keanggotaan staf medis, kewenangan klinis, mekanisme kredensial dan rekredensial, Komite Medik, serta disiplin profesi.

Contoh nyata yang sering saya temui: pasal lama berjudul “Kewenangan” mencampur kewenangan Direktur Utama menetapkan struktur organisasi dengan kewenangan Komite Medik memberikan rekomendasi kredensial. Secara isi memang dua-duanya benar, tetapi menurut struktur baru,

kewenangan Direktur Utama harus berada di bylaws korporasi, sedangkan kewenangan Komite Medik harus berada di bylaws staf medis. Jika dibiarkan campur, saat audit dokumen, penilai akan kesulitan menentukan mana ranah tata kelola dan mana ranah profesi.

Supaya tidak bingung, lakukan langkah praktik sederhana ini di minggu pertama. Anda tidak perlu langsung menulis ulang pasal. C

B A B 2

Struktur Dasar Bylaws Korporasi RS

Bab ini akan memandu Anda menyusun kerangka bylaws korporasi RS yang berfokus pada dua hal inti: tata kelola pemilik dan Direksi. Ini adalah fondasi legal yang menentukan siapa pemegang kekuasaan tertinggi, bagaimana keputusan strategis diambil, dan sejauh mana Direksi boleh bertindak atas nama RS.

> **Catatan: Berdasarkan Permenkes 6/2026, dokumen Hospital Bylaws harus dipisah menjadi dua: bylaws korporasi (tata kelola organisasi) dan bylaws staf medis (tata kelola pelayanan medis). Jangan mencampur kewenangan klinis ke dalam pasal Direksi karena akan memicu pertanyaan saat verifikasi akreditasi.**

Setelah memahami pemisahan ini, langkah praktis menyusun struktur dasar bylaws korporasi RS adalah sebagai berikut:

1. **Tentukan jenis badan hukum RS.** Apakah PT, yayasan, atau unit pelaksana teknis daerah (BLUD)? Ini menentukan istilah pemilik: pemegang saham, pembina, atau pengelola. Sesuaikan dengan anggaran dasar/akta pendirian.
2. **Petakan aktor kewenangan tiga pilar.** Buat tabel sederhana berisi kolom: Pemilik, Direksi, dan Komite Medik. Untuk setiap keputusan strategis (misalnya pengangkatan direktur, perubahan anggaran dasar, kebijakan pelayanan medis), isi siapa yang berwenang. Ini mencegah tumpang tindih pasal.

> 💡 **Tips: Gunakan kertas kerja atau spreadsheet untuk memetakan setidaknya 15 keputusan kunci RS: mulai dari pengangkatan pejabat, pengesahan program kerja, hingga kebijakan mutu dan keselamatan pasien. Hasil pemetaan ini langsung menjadi kerangka pasal-pasal bylaws korporasi.**

3. **Susun pasal tentang Pemilik.** Minimal memuat:
    - Definisi dan identitas pemilik (nama, alamat, porsi kepemilikan).
    - Hak dan kewajiban pemilik, termasuk hak suara, hak mendapatkan laporan, dan kewajiban pendanaan.
    - Mekanisme Rapat Pemilik (RUPS/Rapat Pembina/Rapat Anggota): kuorum, tata cara pemanggilan, dan jenis keputusan yang memerlukan persetujuan pemilik. Contoh: perubahan anggaran dasar, penambahan modal, pembubaran RS, serta pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
4. **Susun pasal tentang Direksi.** Jelaskan:
    - Struktur Direksi (misalnya Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Pelayanan).
    - Persyaratan dan masa jabatan (biasanya 5 tahun, dapat diangkat kembali).
    - Kewenangan Direksi sebagai pengelola harian RS, termasuk menandatangani kontrak, mengangkat pejabat struktural di bawah direktur, dan menyusun kebijakan internal.
    - Batasan kewenangan: Direksi tidak boleh memutuskan hal yang menjadi kewenangan pemilik (misalnya menjual aset tetap di atas nilai tertentu) dan tidak boleh mengintervensi keputusan klinis yang

menjadi ranah Komite Medik.

5. **Tulis pasal dengan bahasa yang operasional.** Hindari frasa ambigu seperti “sesuai ketentuan yang berlaku” tanpa merujuk pasal atau dokumen spesifik. Contoh klausul yang jelas: “Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan triwulanan kepada Pemilik selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah akhir triwulan.”

Sebagai gambaran, berikut contoh potongan pasal tata kelola pemilik:

> **Pasal 5: Rapat Pemilik** 1. Rapat Pemilik merupakan pemegang kekuasaan tertinggi RS. 2. Rapat Pemilik diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. 3. Keputusan Rapat Pemilik yang memerlukan persetujuan suara sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh suara yang sah meliputi: perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian Direksi, serta pembubaran RS. 4. Rapat Pemilik dapat diadakan secara luar biasa atas permintaan tertulis dari 1/3 pemilik atau Direksi.

Dengan mengikuti lima langkah di atas, Anda sudah memiliki kerangka awal bylaws korporasi yang solid dan siap diverifikasi.

INTI BAB: Struktur dasar bylaws korporasi RS harus memuat pasal tata kelola Pemilik dan Direksi secara eksplisit, terpisah dari bylaws staf medis. Mulailah dengan memetakan kewenangan tiga pilar untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan kesiapan verifikasi.

B A B 3

Struktur Dasar Bylaws Staf Medis

Bylaws staf medis adalah “konstitusi” yang mengatur bagaimana para dokter, dokter gigi, dan tenaga medis profesional lainnya menjalankan praktik di rumah sakit. Dokumen ini terpisah dari bylaws korporasi karena mengatur hal-hal yang sangat teknis-klinis: mulai dari mekanisme pemberian kewenangan klinis, pembinaan profesi, sampai penegakan disiplin. Kalau bylaws korporasi bicara soal saham dan Direksi, bylaws staf medis bicara soal Komite Medik dan rincian kewenangan staf.

Kesalahan paling sering terjadi ketika RS mencampur pasal-pasal staf medis ke dalam bylaws korporasi, atau sebaliknya. Akibatnya, saat verifikasi legalitas atau akreditasi, dokumen dianggap tidak sinkron dengan struktur baru Permenkes 6/2026. Padahal kuncinya sederhana: **pisahkan domain, lalu petakan kewenangan secara konsisten.**

Berikut struktur dasar yang wajib ada di bylaws staf medis. Gunakan ini sebagai kerangka, lalu adaptasi dengan kondisi riil RS Anda.

Kerangka Pasal Wajib dalam Bylaws Staf Medis

1. **Ketentuan Umum** – definisi istilah, singkatan, dan rujukan regulasi (UU RS, Permenkes 6/2026, peraturan profesi).
2. **Tujuan dan Ruang Lingkup** – cakupan pengaturan untuk seluruh staf medis yang bekerja di RS, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
3. **Struktur Organisasi Staf Medis** – diagram posisi: Ketua Staf Medis, Komite Medik, subkomite/subsmelt, dan hubungannya dengan Direksi.

4. **Keanggotaan Staf Medis** – syarat menjadi anggota staf medis (STR, SIP, rekomendasi Komite Medik, dll).
5. **Kewenangan Komite Medik** – rincian tugas dan wewenang dalam kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pembinaan etika.
6. **Subkomite dan Tim Kredensial** – pembentukan, komposisi, dan mekanisme kerja subkomite (kredensial, mutu, etika, disiplin).
7. **Kewenangan Klinis dan Penugasan Klinis** – alur penetapan *clinical privilege* dan *clinical appointment*.
8. **Pembinaan dan Penegakan Disiplin Profesi** – mekanisme audit medis, review kasus, sanksi profesi, dan pembelaan.
9. **Rapat Staf Medis** – jadwal, kuorum, dan tata cara pengambilan keputusan.
10. **Perubahan Bylaws Staf Medis** – prosedur revisi dan persetujuan oleh Direksi dan pemilik.

> ⚠ **Penting: Jangan meletakkan kewenangan Komite Medik di bylaws korporasi, dan jangan meletakkan kewenangan Direksi di bylaws staf medis. Komite Medik berwenang pada tataran profesi (kredensial, mutu klinis, etika), sedangkan Direksi berwenang pada tataran manajemen (kontrak, jadwal, alokasi sumber daya). Tumpang tindih di sini adalah penyebab utama dokumen ditolak saat verifikasi.**

Langkah Praktik Menyusun Struktur dari Nol

Ikuti langkah berikut untuk memastikan bylaws staf medis Anda langsung siap adaptasi.

1. **Petakan aktor dan kewenangan.** Buat tabel 3 kolom: Aktor (pemilik, Direksi, Komite Medik, staf medis), Kewenangan, dan Pasal yang mengatur. Isi kolom kewenangan berdasarkan praktik nyata di RS Anda, bukan salinan template. Contoh: Komite Medik → menetapkan standar kredensial → atur di Pasal 5 dan 7.
2. **Buat kerangka pasal berdasarkan daftar 10 pasal di atas.** Jangan mulai dengan menulis isi penuh; cukup buat judul pasal dan sub-pasal terlebih dahulu.
3. **Tulis isi pasal secara ringkas dan operasional.** Gunakan kalimat imperatif: “Komite Medik wajib…” atau “Setiap staf medis harus…” Hindari paragraf panjang yang sulit diuji implementasinya.
4. **Uji silang antar pasal.** Pastikan tidak ada pasal yang saling bertentangan, misalnya Pasal 5 menyatakan Komite Medik menetapkan kredensial, tetapi Pasal 7 malah memberi kewenangan itu kepada Direksi. Koreksi sampai konsisten.
5. **Sinkronkan dengan dokumen turunan.** Setelah struktur inti selesai, buat daftar SPO, kebijakan direktur, dan panduan unit yang harus merujuk ke pasal-pasal tersebut. Tandai dokumen lama yang perlu direvisi.

✅ **Checklist: Verifikasi struktur dasar Anda sebelum lanjut ke bab berikutnya:**

- **Ada pemisahan tegas antara bylaws korporasi dan bylaws staf medis.**
- **Pasal kewenangan Komite Medik mencakup kredensial, mutu profesi, etika, dan disiplin.**
- **Pasal kewenangan staf medis mencakup hak, kewajiban, dan mekanisme pengajuan keberatan.**
- **Tidak ada klausul yang memberi kewenangan klinis kepada pejabat struktural non-medis.**
- **Ada definisi istilah yang konsisten antara bylaws staf medis dan dokumen turunan.**

Dengan struktur dasar ini, Anda sudah memiliki kerangka kerja yang bisa langsung diadaptasi. Bab selanjutnya akan membahas bagaimana memetakan kewenangan pemilik, Direksi, dan Komite Medik ke dalam pasal-pasal secara rinci.

INTI BAB: Bylaws staf medis harus memuat minimal 10 pasal inti yang mengatur kewenangan Komite Medik dan staf secara terpisah dari bylaws korporasi. Kunci keberhasilannya adalah pemetaan kewenangan yang konsisten dan bebas tumpang tindih antara Direksi, Komite Medik, dan staf medis.

B A B 4

Memetakan Kewenangan Pemilik, Direksi, dan Komite Medik

Banyak RS masih menulis klausul seperti “pemilik memberikan arahan strategis”, “Direksi menjalankan operasional”, dan “Komite Medik menjaga mutu” tanpa batas yang tegas. Akibatnya, saat ada keputusan penting—misalnya pengangkatan staf medis fungsional atau pembelian alat besar—muncul tarik-menarik wewenang. Permenkes 6/2026 mendorong pemisahan tegas antara tata kelola korporasi dan tata kelola staf medis. Maka, memetakan kewenangan bukan sekadar latihan legal drafting; ini menentukan kecepatan eksekusi dan kejelasan tanggung jawab.

1. **Mulai dari definisi peran, bukan jabatan.** Tuliskan kalimat satu napas untuk tiga aktor. Contoh:
    - *Pemilik*: pihak yang memiliki atau menyetor modal, berwenang mengangkat/memberhentikan Direksi serta menyetujui perubahan strategis.
    - *Direksi*: organ pengelola harian RS yang berwenang menetapkan kebijakan operasional, struktur organisasi, dan keputusan bisnis dalam batas anggaran.
    - *Komite Medik*: organ yang berwenang memastikan mutu pelayanan medis, kompetensi staf medis, serta memberikan rekomendasi kredensial dan rekredensial. Kalimat sederhana ini menjadi batu uji untuk semua pasal.
2. **Buat tabel matriks kewenangan.** Siapkan tiga kolom: Jenis Keputusan,

Pemilik, Direksi, Komite Medik. Isi 10 keputusan paling sering memicu konflik, misalnya:

- Pengangkatan Direktur RS: Pemilik menyetujui; Direksi tidak berwenang; Komite Medik tidak berwenang.
- Pengangkatan Ketua Komite Medik: Pemilik tidak berwenang; Direksi menetapkan; Komite Medik memberikan rekomendasi kandidat.
- Pemberian kewenangan klinis (*clinical privilege*): Pemilik tidak berwenang; Direksi menerbitkan SK setelah rekomendasi; Komite Medik merekomendasikan.
- Kebijakan keuangan dan anggaran operasional: Pemilik menyetujui anggaran tahunan; Direksi mengusulkan dan mengeksekusi; Komite Medik tidak berwenang, hanya memberi masukan kebutuhan alat medis.
- Pemberhentian staf medis karena pelanggaran etik: Pemilik tidak berwenang; Direksi menindaklanjuti rekomendasi; Komite Medik merekomendasikan sanksi. Matriks ini akan memudahkan saat menyusun pasal-pasal.

3. **Tuangkan matriks ke dokumen yang tepat.** Kewenangan pemilik dan Direksi dimasukkan ke *bylaws korporasi*, terutama bab tentang organ RS, rapat pemilik, dan kewajiban Direksi. Kewenangan Komite Medik dimasukkan ke *bylaws staf medis*, terutama bab tentang organisasi komite, kredensial, dan penegakan disiplin profesi. Jangan mencampur aturan korporasi ke dalam bylaws staf medis, atau sebaliknya.
4. **Uji setiap klausul dengan pertanyaan: “Siapa yang memutuskan, siapa yang merekomendasikan, siapa yang menyetujui?”** Jika bunyi

pasal masih memakai kata “ikut serta”, “berperan aktif”, atau “dapat dilibatkan”, segera ganti dengan kata kerja tegas: menetapkan, merekomendasikan, menyetujui, mengusulkan, atau mengesahkan.

> ⚠ **Penting: Hindari klausul ganda seperti “Direksi dan Komite Medik bersama-sama menetapkan kewenangan klinis.” Dalam verifikasi legalitas, klausul semacam ini dianggap tidak jelas dan membuka ruang sengketa kewenangan. Gunakan satu aktor untuk setiap keputusan final.**

5. **Sinkronkan dengan dokumen turunan.** Setelah pasal-pasal kewenangan selesai, cek apakah SPO, kebijakan Direktur, dan panduan unit masih memuat alur lama. Contoh nyata: jika SPO kredensial masih menyebut “Direktur Utama yang menilai kompetensi dokter”, ubah menjadi “Komite Medik memberikan rekomendasi, Direktur menetapkan.” Perbedaan kecil ini sering terlewat, lalu menjadi temuan akreditasi.
6. **Simulasikan satu kasus nyata.** Ambil contoh pengangkatan kepala instalasi. Buat alur: Kepala Bagian SDM menyiapkan – Komite Medik memberi masukan jika menyangkut pelayanan medis – Direksi menetapkan – Pemilik cukup menerima laporan. Uji apakah alur ini tidak menabrak pasal lain.

✅ **Checklist: (1) Setiap keputusan punya satu aktor final; (2) tidak ada kalimat “ikut serta” tanpa penjelasan peran; (3) kewenangan pemilik tidak masuk ke bylaws staf medis; (4) kewenangan Komite Medik tidak masuk ke bylaws korporasi; (5) SPO turunan sudah disesuaikan dengan matriks kewenangan.**

Dengan pemetaan ini, revisi bylaws tidak akan berhenti di meja legal karena pertanyaan “ini wewenang siapa?” sudah terjawab sejak awal.

INTI BAB: Petakan kewenangan ke dalam tiga kolom sederhana—pemilik, Direksi, Komite Medik—lalu tuangkan ke pasal yang tepat: korporasi untuk organ pengelola, staf medis untuk tata kelola klinis, dan pastikan setiap keputusan memiliki satu penanggung jawab final.

B A B 5

Menyusun Mekanisme Pengambilan Keputusan RS

Mekanisme pengambilan keputusan adalah jantung tata kelola rumah sakit. Tanpa aturan rapat, kuorum, dan pengesahan yang jelas, Direksi bisa terjebak kebuntuan atau keputusan sepihak yang berpotensi digugat. Dalam Hospital Bylaws, bagian ini harus menjawab tiga pertanyaan utama: **siapa yang berhak memutuskan, bagaimana forumnya, dan bagaimana keputusan dinyatakan sah.** Kabar baiknya, Anda tidak perlu menciptakan semua dari nol—cukup adaptasi pola yang sudah lazim dipakai RS yang lulus verifikasi.

Langkah Praktis Menyusun Klausul

1. Petakan forum keputusan strategis.

Identifikasi tiga forum utama yang wajib diatur dalam bylaws:

- **Rapat Pemilik/Pemegang Saham (RUPS)** → untuk perubahan modal, pengangkatan Direksi, pembubaran, atau keputusan struktural yang mengikat pemilik.
- **Rapat Direksi** → untuk kebijakan operasional, rencana anggaran tahunan, kerja sama strategis, dan pengangkatan pejabat struktural di bawah Direksi.
- **Rapat Komite Medik** → untuk kredensial staf medis, telaah mutu klinis, dan rekomendasi etika profesi. Forum ini **tidak boleh** disatukan dengan rapat bisnis Direksi.

2. Tentukan kuorum dan tata cara pengambilan suara.

Jangan biarkan frasa “dihadiri pimpinan” menggantung. Tulis angka konkret.

Contoh klausul yang bisa langsung Anda adaptasi:

> **Contoh Klausul Rapat Direksi:**
> “Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu atas permintaan Direktur Utama atau 2 (dua) anggota Direksi lainnya. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota Direksi. Keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.”

3. Atur pengesahan keputusan strategis khusus.
Ada keputusan yang tidak boleh cukup disahkan lewat rapat Direksi biasa—misalnya pembelian aset di atas ambang tertentu, kerja sama jangka panjang lebih dari 5 tahun, atau pengangkatan pejabat struktural level direktur. Buat klausul pengaman seperti ini:

> **Contoh Klausul Pengesahan Keputusan Strategis:**
> “Keputusan Direksi mengenai pembelian atau pengalihan aset tetap dengan nilai melebihi Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), pengikatan kerja sama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun, serta pengangkatan dan pemberhentian pejabat setingkat kepala unit utama, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Pemilik/RUPS sebelum dinyatakan berlaku.”

4. Buat daftar keputusan strategis dalam lampiran.
Supaya tidak ada kerancuan di kemudian hari, buat tabel berisi kolom: *Jenis Keputusan – Forum Berwenang – Kuorum – Metode Suara – Dokumen*

Pengesahan. Tabel ini menjadi rujukan cepat bagi Direksi dan auditor tata kelola.

> **Tips: Jangan mencampur mekanisme keputusan bisnis dan keputusan klinis dalam satu forum. Keputusan kredensial dokter harus tetap berada di Komite Medik, bukan dirapatkan oleh Direksi. Pencampuran ini adalah salah satu temuan akreditasi paling sering.**

5. Sinkronkan dengan dokumen turunan.

Setelah klausul rapat dan kuorum selesai, pastikan SPO dan kebijakan direktur yang menyangkut pengadaan, kerja sama, atau kepegawaian merujuk pada mekanisme yang sama. Jangan sampai SPO pengadaan memakai kuorum 2 Direktur, sementara bylaws mensyaratkan 3—ini akan dianggap inkonsistensi saat verifikasi.

> **Checklist cepat sebelum menyusun klausul:**
>
> - Sudah ada tabel forum keputusan dan jenis keputusannya?
> - Kuorum ditulis dengan angka pasti, bukan “mayoritas” tanpa definisi?
> - Ada klausul khusus untuk keputusan strategis yang memerlukan persetujuan Pemilik/RUPS?
> - Mekanisme klinis dipisahkan dari mekanisme manajemen?
> - Dokumen turunan (SPO, kebijakan) sudah dicek konsistensinya?

Dengan mengikuti lima langkah di atas, bagian pengambilan keputusan dalam Hospital Bylaws Anda tidak hanya lolos verifikasi legalitas, tetapi juga benar-benar dipakai saat rapat berlangsung—bukan sekadar pajangan di rak tata

kelola.

INTI BAB: Tentukan forum keputusan secara eksplisit, tulis kuorum dengan angka pasti, dan pisahkan tegas antara keputusan bisnis Direksi dan keputusan klinis Komite Medik untuk mencegah kebuntuan dan temuan akreditasi.

B A B 6

Menyinkronkan Bylaws dengan Dokumen Turunan

Setelah draf bylaws korporasi dan bylaws staf medis selesai, pekerjaan belum berhenti. Justru di sinilah titik rawan banyak RS: bylaws baru sudah bagus, tapi SPO, kebijakan direktur, dan panduan unit masih versi lama yang bertentangan. Akibatnya, saat verifikasi legalitas atau akreditasi, tim asesor menemukan inkonsistensi dan menilai tata kelola RS tidak tertib.

Prinsip dasarnya sederhana: **bylaws adalah payung tertinggi di level internal RS**. Semua dokumen turunan—SPO, kebijakan direktur, pedoman pelayanan, hingga instruksi kerja unit—harus selaras. Kalau ada bunyi yang bertentangan, yang kalah adalah dokumen turunan, bukan bylaws. Tapi di lapangan, konflik sering tidak terdeteksi karena tidak ada sistem kendali dokumen.

Berikut langkah praktis menyinkronkan bylaws dengan dokumen turunan.

Langkah 1: Buat peta hierarki dokumen

Jangan mulai dengan membaca semua SPO satu per satu. Mulailah dengan memetakan klausul kunci dari kedua bylaws ke dokumen turunan yang relevan. Buat tabel sederhana di spreadsheet atau dokumen bersama, dengan kolom: **Pasal/klausul bylaws**, **topik**, **dokumen turunan terkait**, **status sinkron**, **tindak lanjut**. Ini memudahkan koordinasi lintas bagian dan mencegah ada klausul yang terlewat.

Langkah 2: Identifikasi klausul kunci yang wajib

diturunkan

Fokus pada klausul yang berdampak langsung ke operasional harian, misalnya: - Kewenangan direksi vs komite medik dalam pengangkatan dan evaluasi staf medis. - Mekanisme pengambilan keputusan untuk kredensial dan kewenangan klinis. - Alur pengesahan kebijakan internal dan SPO. - Definisis istilah seperti “staf medis”, “dokter penanggung jawab pelayanan”, “unit kerja”.

Untuk setiap klausul tersebut, cari SPO atau kebijakan direktur yang seharusnya mengatur detail pelaksanaannya. Jika belum ada, beri tanda untuk segera dibuat. Jika sudah ada, periksa keselarasannya.

Langkah 3: Bandingkan isi secara eksplisit

Ini bukan sekadar membaca cepat. Ambil satu dokumen turunan, buka pasal terkait di bylaws, lalu baca berdampingan. Tanyakan tiga hal: 1. Apakah definisi atau istilah sama persis maknanya? 2. Apakah kewenangan yang disebutkan di SPO masih sesuai dengan pembagian baru di bylaws? 3. Apakah alur atau prosedur di SPO bertentangan dengan mekanisme yang dijamin bylaws?

Contoh nyata: banyak SPO lama menyebut “Direktur menetapkan kewenangan klinis” tanpa melibatkan Komite Medik. Padahal di bylaws staf medis yang baru, kewenangan klinis hanya diberikan setelah rekomendasi Komite Medik. SPO seperti ini harus direvisi.

⛔ **Waspada: Jangan menganggap SPO yang lebih rinci otomatis benar. Justru SPO lama sering kali menjadi sumber konflik karena memuat alur lama pembagian kewenangan yang tidak lagi sesuai Permenkes 6/2026. Periksa setiap kata “berwenang”, “menetapkan”, “mengesahkan”.**

Langkah 4: Lakukan revisi terbatas, bukan menulis ulang semua

Anda tidak perlu membongkar semua SPO. Cukup revisi bagian yang bertentangan, lalu catat perubahan pada header dokumen dan lembar pengesahan. Tetapkan mekanisme agar revisi turunan mengikuti perubahan bylaws: begitu ada pasal di bylaws yang berubah, semua dokumen turunan yang terkait harus ditandai untuk ditinjau ulang dalam waktu tertentu, misalnya 30 hari.

Langkah 5: Uji baca silang oleh unit terkait

Sebelum disahkan, undang kepala unit atau penanggung jawab yang dokumennya terdampak untuk membaca silang draf akhir. Tujuannya memastikan tidak ada prosedur yang kehilangan dasar kewenangan. Gunakan tabel checklist ringkas berikut.

Checklist:

- ☐ Tabel hierarki dokumen selesai dan mencakup semua klausul kunci.
- ☐ Setiap SPO/kebijakan yang bertentangan sudah direvisi atau ditandai untuk revisi.
- ☐ Tidak ada istilah yang didefinisikan berbeda antara bylaws dan turunan.
- ☐ Kewenangan pemilik, direksi, dan Komite Medik konsisten di semua level dokumen.
- ☐ Revisi turunan sudah mendapat pengesahan sesuai alur baru di bylaws.

Setelah sinkronisasi selesai, simpan peta hierarki dokumen itu sebagai dokumen hidup. Verifikasi legalitas dan akreditasi berikutnya akan jauh lebih mudah karena semua tautan antara bylaws dan dokumen turunan sudah terdokumentasi.

INTI BAB: Sinkronisasi bylaws dengan SPO dan kebijakan direktur harus dilakukan dengan peta hierarki dokumen dan pemeriksaan berdampingan, bukan sekadar menyalin struktur baru—konsistensi kewenangan di semua level dokumen adalah kunci lolos verifikasi.

B A B 7

Proses Legal Drafting Internal yang Efisien

Menyusun ulang Hospital Bylaws sering kali berubah menjadi proyek tanpa ujung: draf bolak-balik, rapat melebar, dan revisi yang tidak kunjung selesai. Penyebab utamanya bukan karena materinya sulit, melainkan karena tidak ada kerangka kerja yang membatasi ruang revisi dan memperjelas siapa bertanggung jawab atas bagian apa. Padahal, dengan pendekatan yang tepat, proses legal drafting internal bisa selesai dalam hitungan minggu, bukan bulan.

Berikut langkah kerja praktis yang bisa langsung diterapkan tim penyusun bylaws di rumah sakit Anda.

1. Bentuk tim inti lintas fungsi dan tunjuk satu koordinator.
Tim inti cukup 5–7 orang: perwakilan Direksi, bagian hukum/tata kelola, Komite Medik, keperawatan/SDM, dan satu sekretaris dari unit legal atau sekretariat direksi. Koordinator bertugas mengelola draf, menjadwalkan tenggat, dan menjadi simpul komunikasi. Jangan melibatkan semua kepala unit dalam setiap pembahasan; undang mereka hanya saat membahas klaster pasal terkait.

2. Mulai dari template struktur, bukan dari kertas kosong.
Sebelum menulis, buat daftar isi sementara mengikuti struktur Permenkes 6/2026. Pisahkan tegas Bylaws Korporasi (tata kelola organisasi, pemilik, Direksi, pengambilan keputusan) dan Bylaws Staf Medis (kredensial, kewenangan klinis, disiplin profesi). Template ini menjadi patokan sehingga diskusi tidak melebar ke format atau urutan pasal.

> 💡 **Tips: Buat tabel kewenangan sederhana sebelum menulis pasal. Kolomnya: Keputusan/Kegiatan, Penanggung Jawab, yang Menyetujui, yang Dikonsultasi. Isi untuk 5–10 keputusan kunci, misalnya pengangkatan pejabat struktural, pemberian kewenangan klinis, perubahan anggaran, atau pengesahan SPO. Tabel ini memetakan kewenangan pemilik, Direksi, dan Komite Medik sehingga pasal-pasal yang ditulis tidak salah letak dan tidak memicu revisi besar di kemudian hari.**

3. Bagi pekerjaan per klaster pasal dengan tenggat harian.

Jangan menugaskan satu orang menulis seluruh draf. Bagilah menjadi klaster, misalnya: klaster kepemilikan dan organ RS; klaster Direksi dan pejabat struktural; klaster Komite Medik dan staf medis; klaster pengambilan keputusan dan rapat; klaster ketentuan peralihan. Setiap klaster ditulis oleh orang yang paling memahami substansinya, dengan tenggat 2–3 hari kerja untuk draf awal. Gunakan fitur komentar atau saran pada dokumen bersama (misalnya Google Docs atau Microsoft Word dengan track changes) agar revisi terlacak.

4. Terapkan aturan “1 draf, 2 revisi” sejak awal.

Ini kunci efisiensi. Setelah draf awal terhimpun, setiap unit hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan revisi substantif—terkait legalitas, struktur organisasi riil, atau benturan kewenangan. Revisi kedua hanya untuk perbaikan penulisan, konsistensi istilah, dan sinkronisasi antar-pasal. Usulan di luar itu dicatat sebagai agenda amandemen berikutnya, bukan menghambat pengesahan.

> ⚠️ **Penting: Sepakati batasan ini dalam rapat kick-off dan tulis dalam notulen. Tanpa aturan "1 draf, 2 revisi," setiap unit akan terus mengubah kalimat atau menambah pasal baru setiap kali draf beredar. Akibatnya, draf tidak pernah final dan proses pengesahan mundur berbulan-bulan.**

5. Lakukan sinkronisasi dokumen turunan di tahap akhir.

Sebelum rapat pleno, periksa kesesuaian antara draf bylaws dengan SPO, kebijakan direktur, dan struktur organisasi terbaru. Buat checklist sederhana: apakah nama jabatan sudah sama? Apakah alur kredensial di bylaws staf medis sinkron dengan SPO kredensial? Apakah komposisi pemilik dan direksi sesuai akta terakhir? Tandai ketidaksesuaian dan jadwalkan perbaikan terpisah tanpa menunda pengesahan bylaws, kecuali menyangkut aspek legal yang fatal.

6. Jadwalkan rapat pleno pengesahan dengan agenda tertutup.

Kirim draf final minimal 3 hari sebelum rapat. Agenda rapat hanya dua: persetujuan substansi dan penetapan tanggal sosialisasi. Tidak ada pembahasan redaksional dalam rapat ini. Catat keputusan dalam berita acara dan langsung susun rencana sosialisasi ke seluruh unit kerja.

Dengan mengikuti enam langkah ini, tim penyusun bisa memangkas siklus revisi dari berlarut-larut menjadi terkendali. Hasil akhirnya adalah dua dokumen bylaws yang jelas, sinkron, dan siap diverifikasi.

INTI BAB: Proses legal drafting efisien ditentukan oleh template awal, pembagian peran, dan batasan revisi yang disepakati bersama—bukan oleh jumlah rapat atau lamanya diskusi. Terapkan aturan “1 draf, 2 revisi” dan petakan kewenangan sebelum menulis pasal agar revisi tidak berlarut-larut.

B A B 8

Pengesahan dan Sosialisasi Bylaws Baru

Setelah dokumen bylaws selesai disusun dan direvisi, banyak direksi yang menganggap pekerjaan sudah beres. Padahal, dua tahap terakhir ini justru menentukan apakah dokumen itu menjadi aturan hidup atau hanya tumpukan kertas: pengesahan resmi dan sosialisasi yang benar-benar dipahami unit kerja.

Di banyak RS, kegagalan akreditasi atau temuan verifikasi legalitas bukan karena isi bylaws-nya buruk, tetapi karena proses pengesahannya tidak sah atau bukti sosialisasinya minim. Jadi, perlakukan bab ini sebagai bagian dari proses legal drafting, bukan sekadar formalitas administrasi.

Langkah Praktis Mengesahkan dan Menyosialisasikan Bylaws Baru

1. Lakukan review akhir lintas unit

Sebelum naik ke meja pengesahan, pastikan tidak ada pasal yang saling bertentangan, ambigu, atau melanggar Permenkes 6/2026. Libatkan: - Tim hukum/legal RS - Komite Medik (untuk bylaws staf medis) - Direksi dan perwakilan pemilik - Bagian keperawatan dan unit penunjang jika ada pasal yang menyentuh tugas mereka

Minta masing-masing unit memberi tanda tangan persetujuan pada lembar review. Ini menjadi bukti awal bahwa dokumen sudah melalui koordinasi lintas bagian.

2. Ajukan ke rapat Direksi untuk persetujuan internal

Susun agenda rapat khusus pembahasan final bylaws. Siapkan: - Draft final yang sudah bersih - Matriks perubahan dari versi lama ke baru (jika revisi) - Daftar isu yang sudah diselesaikan selama pembahasan

Hasil rapat harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan notulis. Tanpa berita acara, jejak persetujuan direksi tidak bisa diverifikasi.

> ⚠ **Penting: Bylaws korporasi biasanya memerlukan pengesahan oleh pemilik atau Rapat Pemegang Saham (RUPS) sesuai anggaran dasar RS, bukan hanya SK Direksi. Bylaws staf medis cukup disahkan lewat SK Direksi setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Komite Medik. Jangan mencampur keduanya karena bisa membuat pasal-pasal tertentu batal demi hukum.**

3. Terbitkan Surat Keputusan atau akta pengesahan

Untuk bylaws korporasi: - Jika RS berbentuk PT, siapkan keputusan RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS. - Tuangkan ke dalam akta notaris bila anggaran dasar mensyaratkan perubahan atau penegasan kewenangan.

Untuk bylaws staf medis: - Terbitkan SK Direksi dengan nomor resmi. - Lampirkan rekomendasi Komite Medik sebagai pertimbangan.

Simpan asli dokumen pengesahan di sekretariat direksi. Salinan sah diberikan ke bagian hukum dan unit yang membutuhkan.

4. Sosialisasikan ke seluruh unit kerja

Ini tahap yang paling sering disepelekan. Mengirim PDF lewat email saja tidak cukup. Lakukan langkah berikut:

- **Jadwalkan pertemuan per unit atau per shift** (pagi, sore, malam) agar semua staf mendapat informasi yang sama. Libatkan kepala unit sebagai fasilitator.
- **Buat ringkasan eksekutif** 1–2 halaman berisi poin-poin perubahan utama, kewajiban baru, dan dampak langsung ke pekerjaan harian. Jangan paksa staf membaca 80 halaman penuh.
- **Gunakan media visual** seperti bagan alur kewenangan, tabel perbandingan lama–baru, atau infografis alur pengambilan keputusan.
- **Buka sesi tanya jawab** dan catat pertanyaan yang muncul. Pertanyaan yang berulang bisa menjadi sinyal ada pasal yang perlu dijelaskan ulang atau direvisi.

> 💡 **Tips: Sosialisasi paling efektif jika dikaitkan dengan contoh kasus nyata di unit tersebut. Misalnya, untuk unit keperawatan, tunjukkan bagaimana alur permintaan konsultasi dokter berubah setelah bylaws baru berlaku. Untuk bagian farmasi, jelaskan alur persetujuan penggunaan obat formularium. Dengan begitu staf langsung melihat relevansinya.**

5. Dokumentasikan bukti sosialisasi dan evaluasi pemahaman

Akreditasi rumah sakit mensyaratkan bukti bahwa staf memahami peraturan internal, bukan hanya pernah dikirim file. Siapkan: - Daftar hadir per pertemuan sosialisasi - Notulen singkat setiap sesi - Foto atau rekaman virtual (jika daring) - Surat edaran resmi yang ditandatangani Direktur

Setelah sosialisasi, lakukan evaluasi ringan: kuis singkat untuk kepala unit, supervisi lapangan pada beberapa area, atau wawancara acak dengan staf. Hasil evaluasi ini menjadi bahan perbaikan untuk revisi berkala.

Menutup Proses Legal Drafting

Setelah pengesahan dan sosialisasi selesai, simpan seluruh dokumen dalam satu folder induk: draft final, berita acara rapat, SK pengesahan, bukti sosialisasi, dan hasil evaluasi. Folder ini akan sangat membantu saat akreditasi atau audit legal datang.

Jangan lupa menetapkan jadwal tinjauan berkala—minimal setahun sekali atau setiap ada perubahan regulasi eksternal. Bylaws bukan dokumen mati; ia harus hidup mengikuti perkembangan RS.

INTI BAB: Pengesahan resmi tanpa tahap pengesahan yang sah membuat bylaws kehilangan kekuatan hukum, dan sosialisasi tanpa dokumentasi membuat RS rawan temuan akreditasi; lakukan keduanya secara terstruktur dan simpan buktinya dengan rapi.

B A B 9

Menyiapkan Bylaws untuk Verifikasi Akreditasi

Bylaws bukan sekadar dokumen legalitas; dia adalah cermin tata kelola rumah sakit di mata surveyor akreditasi. Ketika survei berlangsung, surveyor tidak hanya membaca dokumen, tapi juga menguji apakah isi bylaws benar-benar dipraktikkan. Jadi, menyiapkan bylaws untuk verifikasi akreditasi bukan pekerjaan satu malam, melainkan proses menyelaraskan dokumen, pemahaman, dan bukti implementasi.

Apa saja yang biasanya ditanyakan surveyor? Berikut daftar yang paling sering muncul:

- **Struktur organisasi:** Apakah struktur yang tercantum dalam bylaws sesuai dengan struktur terbaru yang disahkan? Apakah ada bagan organisasi resmi yang bisa ditunjukkan?
- **Kewenangan dan tanggung jawab:** Apakah peran pemilik, Direksi, dan Komite Medik sudah dipisahkan dengan jelas? Siapa yang berwenang memutuskan apa, terutama di area klinis vs non-klinis?
- **Proses pengambilan keputusan:** Bagaimana mekanisme rapat Direksi, rapat pemilik, dan rapat Komite Medik? Apakah ada notulen atau bukti rapat?
- **Pengangkatan dan pemberhentian pejabat:** Apakah ada alur jelas untuk pengangkatan Direktur, kepala unit, atau ketua Komite Medik? Apakah sesuai dengan aturan internal dan perundangan?
- **Medical staff bylaws:** Apakah ada dokumen terpisah yang mengatur keanggotaan staf medis, kredensial, kewenangan klinis (privileges), dan

evaluasi kinerja? Apakah proses peer review berjalan?

- **Sinkronisasi dokumen turunan:** Apakah SPO, kebijakan direktur, dan panduan unit merujuk pada pasal-pasal dalam bylaws yang sama? Atau malah bertentangan?
- **Sosialisasi dan pemahaman:** Apakah ada bukti sosialisasi bylaws ke seluruh unit? Apakah petugas kunci bisa menjelaskan isi bylaws dengan benar?
- **Evaluasi dan revisi:** Apakah ada mekanisme peninjauan berkala bylaws? Kapan terakhir direvisi dan apa alasannya?

Itu baru sebagian. Intinya, surveyor ingin melihat konsistensi antara dokumen dan praktik sehari-hari.

> ✅ **Checklist: Sebelum survei, pastikan Anda memiliki: (1) dokumen corporate bylaws dan medical staff bylaws terpisah, (2) bagan organisasi terbaru yang disahkan, (3) notulen rapat pemilik/Direksi/Komite Medik, (4) daftar pejabat struktural yang masih berlaku, (5) bukti sosialisasi, dan (6) matriks ketertelusuran antara pasal bylaws dengan SPO/kebijakan terkait.**

Langkah praktis menyiapkan bylaws untuk verifikasi akreditasi:

1. **Lakukan gap analysis.** Bandingkan isi bylaws saat ini dengan struktur yang diminta Permenkes 6/2026 dan praktik nyata di RS. Buat daftar ketidaksesuaian dan prioritaskan yang berdampak langsung pada keselamatan pasien dan tata kelola.
2. **Sinkronkan dokumen turunan.** Pastikan setiap kebijakan, SPO, atau panduan unit yang menyebut wewenang atau alur kerja merujuk pada

pasal yang tepat di bylaws. Jangan sampai ada SPO yang menyebut Direktur Utama padahal di bylaws sudah berganti jabatan.

3. **Susun bukti implementasi.** Kumpulkan notulen rapat, surat keputusan pengangkatan, formulir kredensial, dan dokumen evaluasi. Simpan dalam satu folder khusus yang mudah diakses saat survei.
4. **Lakukan simulasi wawancara.** Latih para pejabat kunci—Direksi, Ketua Komite Medik, kepala unit—untuk menjelaskan isi bylaws dengan bahasa sederhana. Surveyor sering menguji pemahaman, bukan sekadar hafalan.
5. **Perbaiki inkonsistensi sebelum survei.** Jika ditemukan perbedaan antara praktik dan dokumen, segera revisi dokumen atau ubah praktiknya. Lebih baik merevisi bylaws dan mensosialisasikannya daripada membiarkan celah.
6. **Siapkan mekanisme peninjauan berkala.** Tunjukkan bahwa bylaws bukan dokumen mati. Jadwalkan evaluasi tahunan dan dokumentasikan hasilnya.

> ⛔ **Waspada: Jangan menggabungkan corporate bylaws dan medical staff bylaws dalam satu dokumen hanya agar terlihat ramping. Surveyor akreditasi akan menilai keterpisahan dokumen sebagai indikator kepatuhan terhadap Permenkes 6/2026, dan penggabungan akan dianggap sebagai temuan tata kelola.**

Dengan persiapan yang matang, verifikasi akreditasi bukan lagi momok. Bylaws yang rapi dan dipahami bersama akan memperkuat posisi RS di mata surveyor.

INTI BAB: Siapkan bylaws sebagai bukti tata kelola yang hidup, bukan sekadar dokumen; pastikan keterpisahan corporate dan medical staff bylaws, sinkronkan dengan praktik, dan latih pemahaman para pemangku kepentingan sebelum survei akreditasi.